EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	: 86953
SERVICIO	: MEDICINA HSC		
FECHA	: 2024-06-19 11:35:00		

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: BERTA DE LAS ROSAS ARAVENA CARRASCO			**RUN**	: 6.807.892-K
F.Nac	: 10-02-1943	**Edad**	: 81 AÑOS, 4 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: MATTA 0246			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-06-08	**Fecha Egreso**	: 2024-06-19 11:35:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: DOMICILIO	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACVs isquémicos talámico derecho anterolateral, mesencefalico inferior derecho, pedúnculos cerebelosos superior y medio derechos, cerebeloso supero-anterior derecho, etiología ATE intracraneana
-Neumonía aspirativa ATB 10/10 (ceftriaxona/metronidazol 2, ampicilina/sulbactam 7)
-Retención urinaria aguda
-Disfagia neurogénica
-Ant: HTA - ACV secuelado reciente (2/2/24) - Cardiopatía coronaria (cx revascularización miocárdica) - EPOC - Deterioro cognitivo - mRS 3-4

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

REG, HDN estable, RS al monitor, sin requerimientos de O2, eupneica, afebril, no refiere molestias, estacionaria en lo neurológico, tolera bien alimentación por SNG (con buen pronóstico de recuperación de disfagia) pero con escasa cooperación para avanzar en deglución, sin nauseas/vómitos. Mantiene inestabilidad de tronco en sedestación (requiere 2 operadores), no coopera para avanzar en rehabilitación motora en bípedo.
AngioTC cerebro y cuello muestra estenosis multifocal >50% en ambas ACPs, 30-40 en 1/3 medio de AB, AV der hipoplásica. TC cerebro inicial mostró solo infarto talamico derecho agudo (y lesiones isquémicas secuelares frontal izquierda, talámica , occipital derecha y cerebelosa postero-inferior medial izquierda), 2° TC cerebro de control mostró infartos talámico derecho anterolateral, mesencefalico inferior derecho, pedúnculos cerebelosos superior y medio derechos, cerebeloso supero-anterior derecho; sin TH.
Inicio DAPT c/carga (AAS + clopidogrel) por etiología ATE intracraneana.
Completó tto ATB por neumonía aspirativa. Por epigastralgia cambio clopidogrel por cilostazol e inicio omeprazol, suspendo famotidina.
Dep(-), diuresis(+) por sonda vesical, nueva retención urinaria la retirarla por lo que se decide mantenerla.
En vista de la estabilidad clínica se decide alta domicilio hoy, continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica en HODOM, mantener DAPT y control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-12 días.

PLAN DE MANEJO:

-Alta domicilio hoy
-Continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica en HODOM
-Mantener DAPT por al menos 3 meses
-Control ambulatorio en policlínico de Neurología en 10-12 días

INDICACIONES AL ALTA

1. -Aspirina 100 mg/día
2. -Cilostazol 100 mg c/12 horas
3. -Omeprazol 20 mg/día
4. -Atorvastatina 40 mg 2 comp/noche
5. -Ipratropio 2 puff c/8 horas SOS si tos o sibilancias
6. -Losartan 50 mg c/12 horas
7. -Bisoprol 2.5 mg 1/2 comp al día
8. -Amlodipino 10 mg/día
9. -Hidroclorotiazida 50 mg/día
10. -Hidralazina 50 mg c/6 horas
11. -Tamsulosina 0.4 mg/noche
12. -Polietilenglicol 1 sobre/día SOS si constipación mayor a 2 días

EXÁMENES Y RESULTADOS

14/6/24
-Alb 3.5
-Crea 0.7 MDRD 80.31
-AU 3.3
-Ca 9.2
-FA 72 BI 0.55 BD 0.25 BT 0.8 GOT 31 GPT 30 GGT 29
-PCR 8
-Na 142 K 4.1 Cl 104
-Leu 9200 Hb 13.9 Plaq 346000 Seg 85 VHS 26
-Procal 0.06
-OC GR 10-25

11/6/24
-Crea 0.7 MDRD 80.31 Uremia 42
-PCR 41.1
-Na 143 K 4 Cl 103
-Leu 8600 Hb 12.3 Plaq 304000 Seg 66 VHS 15
-Pro BNP 356
-Trop 12.2
-Procal 0.07
-GSA

10/6/24
-Glic 116
-Crea 0.8 MDRD 68.84 Uremia 43
-Ca 8.6
-LDH 182
-Lact 0.9
-PCR 52.4
-Mg 2.1 Na 141 K 4 Cl 100
-Hb 13 Leu 10900 Plaq 291000 Seg 69
-INR 1.03
-TSH 1.344 T4L 0.65
-B12 283

8/6/24
-Crea 1 MDRD 53.21 Uremia 43
-PCR <5

-Na 138 K 4 Cl 100
-Leu 12500 Hb 12.4 Plaq 344000 Seg 71 VHS 8

7/6/24
-OC N
-Urocultivo(-)
-Alb 4.1
-Crea 1 MDRD 53.21 Uremia 37
-AU 5.7
-Ca 9.1 P 4 Na 142 K 4.4 Cl 103
-FA 62 BI 0.28 BD 0.12 BT 0.4 GOT 22 GPT 20 GGT 27
-CKMB 18 CK 44
-ColT 143 HDL 47 LDL 66 VLDL 30.4 TG 152
-LDH 152
-Lact 1.3
-PCR 5
-Hb 13.1 Leu 7400 Plaq 377000 Seg 46
-INR 0.91 TTPA 26
-Trop 11.9
-TSH 3.131 T4L 0.71

OBSERVACIONES:

Ex fco gral
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T no ausculto soplos
-Pulmonar: MP(+) SRA, sin uso de musculatura accesoria
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico
-Mental: vigil, desorientada en tiempo y orientada en espacio, confusión y bradipsiquia leves, lenguaje hipofluente, nomina 3/3, repite frases cortas, comprende órdenes de 3 pasos sin cruzar linea media
-PC: CV impresiona hemianopsia derecha por amenaza, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, mirada conjugada en infraversión (mas acentuado a izq -al ingreso solo con hipotropia OI), ROC horizontales impresiona muy hipoactivos a ausentes, ROC horizontal solo ascendente conservado, impresiona ausencia MOE horizontales voluntarios (ofalmoplejia de la mirada horizontal y vertical ascendente), PFC izq moderada, disartria moderada, hipofonía moderada, sensibilidad facial algésica conservada con maniobra de Foix, nistagmo(+) vertical descendente, úvula central, lengua desviada a izquierda, fuerza ECM impresiona M5, fuerza trapecio derecho M5 e izquierdo M0
-Motor: ESD M5, EID M3, ESI M1-2 EII M2, RCP extensor bilateral
-Sensibilidad: algesia impresiona disminuida en ESI
-Cerebelo: n/e
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO